2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

PRESSÃO ALTA, ADESÃO BAIXA: REFLEXÕES SOBRE O MANEJO DA HIPERTENSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Lays Lins da Silva[1], Lyzandra Holanda Lopes Beserra[1], Carlos Vinícius Barbosa de Farias Pinto[1], Patrícia Almeida Lira Santos Veiga[1], Igor Duarte de Oliveira[1]

[1]Universidade Federal de Alagoas

Fluxograma do manejo da hipertensão e dos fatores relacionados à adesão ao tratamento na Atenção Primária.

PRINCIPAIS ACHADOS

- Baixa adesão ao tratamento da HAS, evidenciada por relatos dos pacientes e pressão arterial não controlada.
- Principais barreiras: baixa compreensão da doença, esquecimento, crenças populares e dificuldade em mudanças no estilo de vida.
- Educação em saúde com linguagem acessível e simplificação das prescrições favoreceram maior compreensão do tratamento.
- Vínculo com a equipe e acompanhamento longitudinal na APS mostraram-se fundamentais para melhorar a adesão terapêutica.

Introdução

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição altamente prevalente e um dos principais fatores de risco cardiovascular. Embora a Atenção Primária à Saúde (APS) seja o principal cenário de acompanhamento desses pacientes, a adesão terapêutica permanece como um desafio frequente, impactando diretamente o controle da doença e a prevenção de complicações.

Objetivos

Relatar a experiência de atendimentos em cardiologia realizados por estudantes de medicina em uma Unidade Básica de Saúde, destacando as principais barreiras observadas na adesão ao tratamento da hipertensão arterial.

Métodos

Trata-se de um relato de experiência baseado em atendimentos de cardiologia realizados por estudantes de medicina, sob supervisão docente, em uma Unidade Básica de Saúde do município de Arapiraca–AL.
Durante os atendimentos, foram observados aspectos relacionados ao controle pressórico e à adesão ao tratamento, considerando relatos dos pacientes, uso regular das medicações prescritas e medidas de pressão arterial aferidas durante as consultas.
A partir dessas observações, foram identificadas barreiras recorrentes à adesão terapêutica, bem como discutidas estratégias de intervenção voltadas à educação em saúde, simplificação do regime terapêutico e incentivo ao acompanhamento longitudinal na APS.

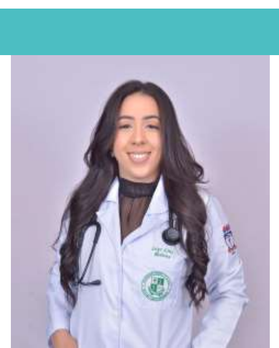
Resultados

Durante os atendimentos, observou-se que a baixa adesão ao tratamento da hipertensão esteve frequentemente associada a diferentes fatores.
Entre as principais barreiras identificadas destacaram-se:
• Baixa compreensão dos pacientes sobre a natureza crônica da doença e seus riscos a longo prazo.
• Esquecimento do uso das medicações, especialmente em pacientes em uso de múltiplos fármacos.
• Crenças populares e interpretações equivocadas sobre a necessidade do tratamento contínuo, principalmente na ausência de sintomas.
• Dificuldade de adesão às mudanças no estilo de vida, como redução do consumo de sal, prática regular de atividade física e controle do peso corporal.
Diante dessas dificuldades, foram realizadas intervenções educativas individualizadas, utilizando linguagem acessível para explicar os riscos da hipertensão não controlada e a importância do tratamento contínuo. Também foi incentivado o acompanhamento regular na UBS, fortalecendo o vínculo entre pacientes e equipe de saúde

Conclusão/Considerações finais

A adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica configura-se como um desafio multifatorial, envolvendo aspectos clínicos, comportamentais e socioculturais.
A experiência vivenciada evidencia que a Atenção Primária à Saúde constitui um espaço estratégico para o enfrentamento dessa problemática, por meio do acompanhamento longitudinal, da construção de vínculo entre profissionais e pacientes e da implementação de ações de educação em saúde.
Essas estratégias contribuem para ampliar a compreensão dos pacientes sobre a doença e favorecer uma maior adesão ao tratamento, fortalecendo o cuidado integral e a prevenção de complicações cardiovasculares.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – Campus Arapiraca
LAYS LINS DA SILVA - layslins10@gmail.com
ACADÊMICA DE MEDICINA



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS